

가상 건강검진 결과지

Health Check Summary

수검자 정보

성명: 한지민 성별/생년월일: 여 / 1959.12.24 나이: 만 66세
기저질환: 고혈압, 관절염, 심근경색 병력 검진일: 2026.07.09 문서번호: VHC-20260709-HJM-006

혈압 135/92 mmHg 고혈압 관리 필요	혈당 93 mg/dL 정상 범위	BMI 30.4 비만 1단계
체지방률 46.3 % 높음	골격근량 17.7 kg 낮음 / 근감소 위험	심박 69 bpm 정상 안정시 심박

측정 항목별 판정

항목	측정값	판정	의미 및 확인사항
심박	69 bpm	정상	안정시 심박은 정상 범위로 추정
혈당	93 mg/dL	정상	공복혈당 기준 정상 범위이나 당뇨 위험요인 정기 추적 필요
혈압	135/92 mmHg	고혈압 관리 필요	이완기 혈압이 높아 반복 측정 및 약물 순응도 확인 필요
몸무게	74 kg	주의	BMI 및 체지방률과 함께 체중 관리 필요
BMI	30.4	비만 1단계	심혈관질환 병력 고려 시 감량 목표 설정 권고
골격근량	17.7 kg	낮음	고령 및 관절염을 고려한 근감소 위험 평가 필요
체지방률	46.3 %	높음	복부비만·대사질환 위험 증가 가능성 확인 필요

종합 판정

혈당 93 mg/dL과 심박 69 bpm은 양호하나, 혈압 135/92 mmHg로 이완기 혈압이 높고 BMI 30.4 및 체지방률 46.3%로 비만 및 체지방 과다 소견이 있습니다. 고혈압과 심근경색 병력이 표시되어 있어 심혈관 재발 위험 관리가 중요합니다. 골격근량 17.7 kg은 낮은 편으로 관절염을 고려한 안전한 근력운동과 재활성 운동 처방이 필요합니다.

진단 요약

구분	가상 진단명	근거	관리 수준
1	고혈압 조절 미흡 의심	혈압 135/92 mmHg, 고혈압 병력	진료 권고
2	비만 1단계 및 체지방 과다	BMI 30.4, 체지방률 46.3%	적극 관리
3	근감소 위험 및 운동기능 저하 가능성	골격근량 17.7 kg, 고령, 관절염	운동 처방
4	심근경색 병력에 따른 심혈관 고위험군	기저질환 태그 심근경색	정기 추적

의사 소견 - 가상

- 현재 수치만으로 급성 이상을 단정할 수는 없으나, 심근경색 병력이 있는 고혈압 환자로 분류되어 혈압 조절 목표와 약물 복용 상태 확인이 필요합니다.
- 혈당은 정상 범위이나 비만과 체지방 과다가 있어 당뇨병, 이상지질혈증, 지방간 등 대사질환 선별검사를 정기적으로 시행하는 것이 좋습니다.
- 골격근량이 낮고 관절염 병력이 있으므로 무릎·고관절 부담을 줄이는 저충격 유산소 운동과 점진적 근력운동을 권고합니다.
- 심근경색 병력자는 흉통, 호흡곤란, 식은땀, 갑작스러운 피로감이 발생하면 즉시 진료 또는 응급평가가 필요합니다.
- 체중 감량은 단기간 급감량보다 3-6개월에 체중의 5-7% 감량을 목표로 식사·운동·수면을 함께 조정하는 방식이 적절합니다.

권고 검사 및 추적관리

항목	권고 내용
혈압/심혈관	가정혈압 기록, 심전도, 지질검사, 심장내과 추적진료 권고
대사질환	HbA1c, 지질검사, 간기능, 신장기능, 요단백/미세알부민 검사 고려
근감소/관절	보행속도, 악력, 낙상위험 평가 및 물리치료·운동처방 상담
생활습관	저염식, 체중감량, 금연, 절주, 수면관리, 약물 복용 순응도 확인

중요 안내

아래 처방은 데이터 기반 시뮬레이션을 위한 가상 예시입니다. 실제 복용, 조제, 보험청구, 의료기관 제출에 사용할 수 없습니다. 실제 약물은 의사의 진료와 검사 결과에 따라 결정되어야 합니다.

수진자 및 처방 정보

성명	한지민	성별/생년월일	여 / 1959.12.24
처방일	2026.07.09	진단 참고	고혈압, 비만, 심근경색 병력
의료기관	헬스업 가상의원	담당의	AI 가상 주치의

가상 처방 내역

분류	가상 처방 예시	용법	기간	비고
고혈압 관리	기존 혈압약 복용 여부 확인 및 조절 상담	의사 판단	2-4주	가정혈압 기록 지참
심혈관 병력	항혈소판제/지질강하제 복용 여부 확인	의사 판단	상시	심장내과 처방 확인 필요
관절 통증	관절염 통증 평가 후 약물·물리치료 상담	의사 판단	필요 시	임의 복용 금지
체중/근감소	영양상담 및 저충격 운동 처방	주 3-5회	12주	낙상·통증 주의

생활 처방

영역	권고 내용
식이	하루 염분 섭취를 줄이고, 단백질·채소 중심 식사와 정제 탄수화물 제한을 권고합니다.
운동	관절 부담이 낮은 걷기, 실내자전거, 수중운동과 가벼운 저항운동을 병행합니다.
혈압관리	아침/저녁 안정 후 혈압을 측정하여 기록하고, 수축기/이완기 상승이 반복되면 진료를 받습니다.
심혈관 주의	흉통, 호흡곤란, 식은땀, 왼팔·턱 통증 등 증상이 있으면 즉시 응급평가가 필요합니다.